SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA — PRONTUÁRIO MÉDICO ELETRÔNICO (DOC-MED-002)

Laudo Clínico e Endoscópico: Úlcera Péptica Gástrica Associada a H. pylori e Uso de AINEs

ID Prontuário:	**DOC-MED-002**	**Paciente:**	**P-02 (Helena Vasconcelos Silva)**	**Idade / Sexo:**	54 anos | Feminino
Antropometria:	66 kg | 1,61 m (IMC: 25,4 kg/m²)	**Data/Hora:**	11/11/2026 - 09:15h	**Código CID-10:**	**K25.4 (Úlcera gástrica crônica ou não especificada com hemorragia)**

Mapeamento Semântico e Resolução de Entidades (KAG Ontologia): Diagnóstico Canônico: Úlcera Péptica Gástrica (Aliases: Úlcera Estomacal, Doença Ulcerosa Péptica). Agente Etiológico: Helicobacter pylori (Aliases: H. pylori). Fármacos: Omeprazol (Aliases: Losec), Ácido Acetilsalicílico (Aliases: AAS, Aspirina).

1. ANAMNESE, HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL (HDA) E ANTECEDENTES

Paciente feminina, 54 anos, professora, comparece ao ambulatório especializado de gastroenterologia encaminhada após episódio de evacuação escura e fétida compatível com melena há 48 horas, precedida por quadro arrastado de 4 semanas de dor epigástrica urente (epigastralgia em queimação), plenitude pós-prandial precoce, náuseas matinais e perda ponderal de 3 kg no período.

Durante a revisão farmacológica detalhada, a paciente relata uso diário e contínuo de Ácido Acetilsalicílico (AAS / Aspirina) 100 mg/dia e anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) nos últimos 8 meses por automedicação para dores articulares e profilaxia cardiovascular empírica, sem proteção gástrica associada.

2. EXAME FÍSICO DIRECIONADO E PROPEDÊUTICA COMPLEMENTAR

Parâmetro Clínico / Exame de Imagem	Achados Objetivos e Descrição Propedêutica
Sinais Vitais	PA: 118/74 mmHg | FC: 88 bpm | FR: 16 irpm | SpO2: 98% | Temp: 36,6 °C
Exame Abdominal	Abdome plano, flácido, ruídos hidroaéreos normoativos, doloroso à palpação superficial e profunda em região epigástrica, sem sinais de irritação peritoneal (Sinal de Blumberg negativo).
Endoscopia Digestiva Alta (EDA)	Esôfago normal. Estômago apresentando lesão ulcerada ovalada de 1,4 cm em pequena curvatura do antro gástrico, bordas elevadas e regulares, fundo recoberto por fibrina espessa com hematina aderida (Classificação de Forrest IIc). Bulbo duodenal íntegro.
Pesquisa de Urease e Histopatologia	Teste rápido da urease francamente POSITIVO em biópsia de antro e corpo gástrico, confirmando colonização ativa por bacilos espiralados Gram-negativos (Helicobacter pylori).

3. PAINEL DE BIOMARCADORES E EXAMES LABORATORIAIS

Exame / Biomarcador Analisado	Resultado Obtido no Paciente	Valor de Referência / Interpretação
Hemoglobina / Hematócrito	**10,4 g/dL / 31,8%**	12,0 - 15,5 g/dL (Anemia Ferropriva Leve)
Ferritina Sérica	**18 ng/mL**	30 - 200 ng/mL (Reduzida)
Ureia / Creatinina	**48 mg/dL / 0,85 mg/dL**	Ureia elevada por digestão de sangue no TGI
Teste Respiratório C13-Ureia	**Positivo (Delta > 12,5‰)**	< 4,0‰ (Negativo)
Plaquetas / Coagulograma	**290.000 /mm³ | TP/TTPA normais**	150.000 - 450.000 /mm³
Gastrina Sérica Basal	**52 pg/mL**	< 100 pg/mL

4. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO E FISIOPATOLOGIA / ETIOLOGIA (CAUSAS)

A patogênese da Úlcera Péptica Gástrica (Úlcera Estomacal) nesta paciente resulta do sinergismo lesivo entre dois fatores etiológicos diretos: (1) a infecção crônica pela bactéria Helicobacter pylori (H. pylori), que produz urease e citotoxinas (CagA/

VacA) degradando a camada de muco protetor; e (2) a inibição sistêmica e tópica das enzimas ciclo-oxigenase (COX-1) provocada pelo uso contínuo de Ácido Acetilsalicílico (AAS / Aspirina), bloqueando a síntese de prostaglandinas citoprotetoras (PGE2) e causando isquemia microvascular da mucosa.

5. PLANO TERAPÊUTICO, PRESCRIÇÃO FARMACOLÓGICA E CONDUTA CLÍNICA

1. Suspensão Imediata do Agente Agressor: Interrupção definitiva do uso desnecessário de Ácido Acetilsalicílico (AAS) e demais anti-inflamatórios não esteroidais.

2. Terapia Tríplice de Erradicação de Helicobacter pylori (14 dias):

• Omeprazol (Losec) 40 mg VO 12/12h em jejum (Inibidor da Bomba de Prótons - H+/K+ ATPase), mantido por 8 semanas adicionais para cicatrização completa da lesão ulcerada;

• Amoxicilina 1.000 mg VO 12/12h por 14 dias;

• Claritromicina 500 mg VO 12/12h por 14 dias.

3. Controle Endoscópico de Cura: Agendada nova Endoscopia Digestiva Alta após 8 semanas com pesquisa de erradicação bacteriana.

[ALERTA DE GRAFO KAG - FARMACODINÂMICA E INTERAÇÕES MULTI-HOP]:

• Inibição Enzimática Hepática CYP2C19 (Conexão Direta com DOC-MED-001): O medicamento Omeprazol (Losec) é um potente inibidor da isoenzima hepática CYP2C19. Caso um paciente com Infarto Agudo do Miocárdio (DOC-MED-001) em uso do antiagregante Clopidogrel (Plavix) desenvolva Úlcera Péptica induzida pelo AAS, o Omeprazol NÃO deve ser utilizado, pois bloqueia a ativação metabólica do Clopidogrel via CYP2C19 e causa falha terapêutica grave (trombose aguda de stent).

• Causalidade Cruzada por Salicilatos: O fármaco Ácido Acetilsalicílico (AAS), pilar do tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (DOC-MED-001), atua simultaneamente como causa etiológica direta da Úlcera Péptica Gástrica (DOC-MED-002) e agente desencadeador de hemorragia grave na Dengue Clássica (DOC-MED-004).